

SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

Perioperative Pressure Injury Prevention



25/09/2026

SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

หัวข้อนำเสนอ

- ❖ ความหมาย สาเหตุการเกิด และการแบ่งระดับของแผลกดทับ
- ❖ แผลกดทับในห้องผ่าตัด และประเภทแผลอื่นๆที่พบ
- ❖ แนวทางการป้องกันแผลกดทับในห้องผ่าตัด
- ❖ การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

แผลกดทับ (Pressure Injury)

การถูกทำลายเฉพาะที่ของผิวหนังและ/หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (Localized damage to skin and/or underlying tissue)

Epidermis
Dermis
Hypodermis (fat)
Muscle
Bone

ลักษณะการบาดเจ็บอาจพบได้ทั้งแบบ

- ผิวหนังที่ intact การรักษา (Intact skin)
- เกิดเป็นแผลเปิด (Open ulcer)

มักเกิดขึ้นบริเวณกระดูก (Bony prominences) หรือสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ (Medical devices).

<https://www.courtesy.com/media/778353/view/skin-anatomy-illustration>

SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

ปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้เกิดแผลกดทับแรงกด (Pressure)

กลไกการเกิดแผลกดทับ (The Pathophysiology of Injury)

สภาวะแรงกด (Pressure > 32 mmHg) + ระยะเวลา (Time) → เนื้อเยื่อขาดเลือด (Reduced Perfusion) → การขาดเลือด (Ischemia) → การตายของเนื้อเยื่อ (Tissue Death)

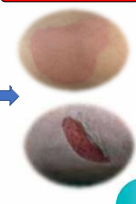
เมื่อเนื้อเยื่อขาดเลือด จะเปลี่ยนเป็นแผลกดทับ

ระยะเวลาที่ 32 mmHg เป็นเวลาที่ยอมรับได้ 6 ชั่วโมง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)

- ความทนทานของเนื้อเยื่อ (Tissue tolerance)
- ความชื้นของผิวหนัง (Moisture)

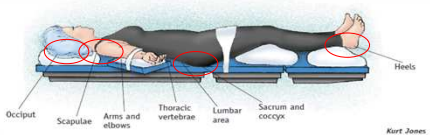
แผลกดทับ : Pressure Injury



SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

Pressure point



Supine position

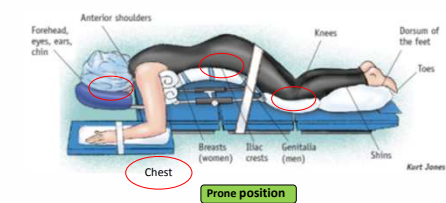
Kurt Jones

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44010-1_30

SIRIRAJ 138

Mahidol University
Dhulung Ph. Jant

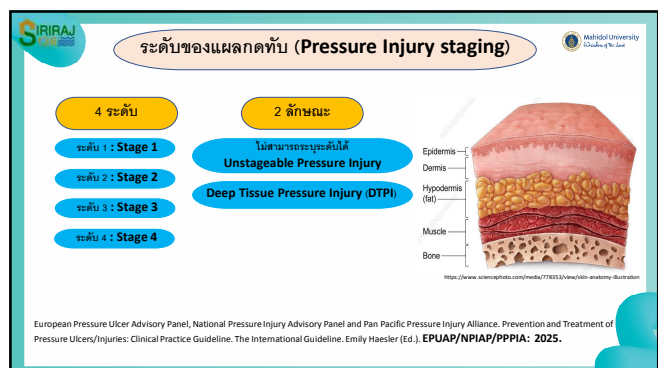
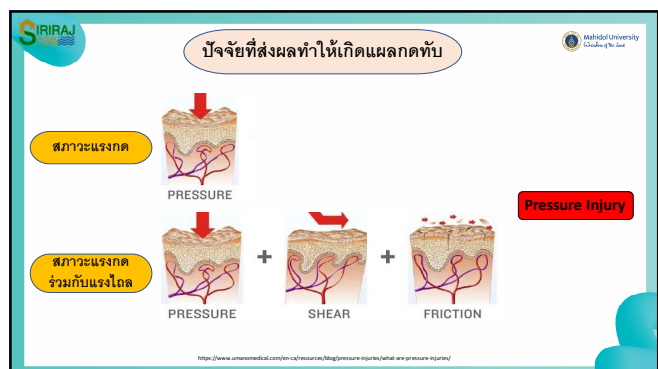
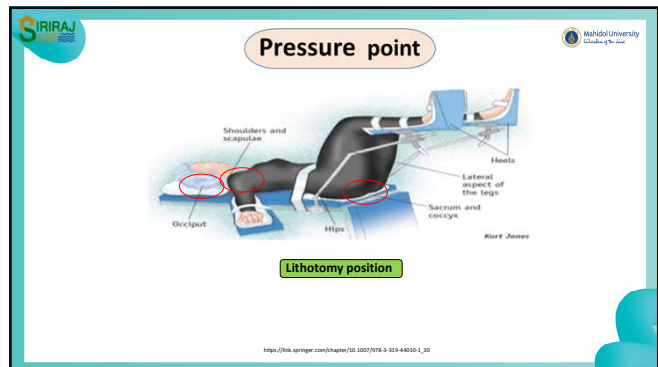
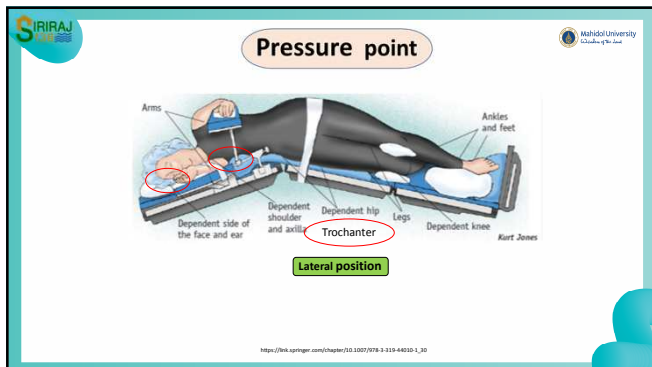
Pressure point

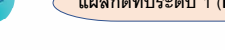


Prone position

Kurt Jones

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44010-1_30





Blanchable vs Non-Blanchable

Blanchable Non-Blanchable



Mahidol University
Chulalongkornrajavidyalaya University

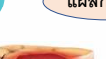
ผลกดทับระดับ 1 (Pressure Injury stage 1)



Non-blanchable erythema of intact skin

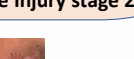


- ❖ ผิวหนังยังไม่เกิดการฉีกขาด
- ❖ มีรอยแดง และรอยแดงยังคงอยู่ เมื่อใช้นิ้วมือกด



NPAP





❖ **ตุ่มน้ำใส หรือเป็นตุ่มน้ำใสที่แตกแล้ว**



Epidermis
Dermis
Subcutis
Muscle

❖ **สูญเสียชั้นผิวหนังบางส่วน**

❖ **มองเห็นชั้นหนังแท้**

Partial-thickness skin loss with exposed dermis, viable, pink or red, moist. Intact/ruptured serum-filled blister (granulation tissue, slough and eschar are not present)

SIRIRAJ

แผลกดทับระยะที่ 4 (Pressure Injury stage 4)

- สูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมดและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- มองเห็นหรือสัมผัสชั้นเนื้อเยื่อที่มี กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกอ่อน หรือกระดูก
- บริเวณพื้นแผลอาจพบเนื้องาเปื่อยช้ำ และ/หรือนี้อาจแห้งแข็ง
- มักพบขอบแผลฉนวนดำ แผลเป็นโพรงได้รอบแผล และ/หรือแผลเป็นโพรง

Full-thickness skin and tissue loss, exposed or directly palpable fascia, muscle, tendon, ligament, cartilage or bone. Slough and/or eschar may be visible. Epibole (rolled edges), undermining and/or tunneling often occur.

แผลกดทับที่ไม่สามารถระบุระดับ
Unstageable Pressure Injury



- ❖ สูญเสียชั้นผิวหนังทั้งหมดและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
- ❖ พื้นแผลถูกปกคลุมด้วยเนื้อตายทั้งหมด
- ❖ จะสามารถระบุแผลกดทับได้เมื่อกำจัดเนื้อตายออกแล้ว

Obscured full-thickness skin and tissue loss, it is obscured by slough or eschar.

แผลกดทับที่มีการบาดเจ็บเนื้อเยื่อชั้นลึก
Deep Tissue Pressure Injury (DTPI)



- ❖ มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวเป็นสีแดงเข้มหรือสีม่วง ผิวหนังจึกขาดไม่จึกขาดตุ่มน้ำปื้นเลือด

Intact/non intact skin persistent non-blanchable deep red maroon or purple discoloration or blood-filled blister

แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

แผลกดทับที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นแผลกดทับเฉพาะที่ของผิวหนังที่เกิดจากการกดทับของอุปกรณ์ เช่น Positioning device, Mouth retractor, ET tube, Tourniquets, อุปกรณ์ที่ใช้ monitor ผู้ป่วย, อุปกรณ์ที่ใช้ยึดตัวผู้ป่วย เป็นต้น

เกิดบริเวณผิวหนังสามารถระบุระดับของแผลกดทับได้ เช่นเดียวกับ Pressure Injury

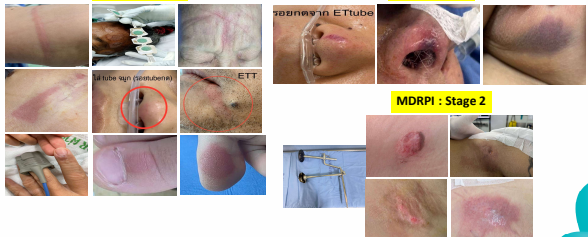


แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
Medical Device Related Pressure Injury : MDRPI

MDRPI Stage 1

MDRPI : DTPI

MDRPI : Stage 2



แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
Medical Device Related Pressure Injury : MDRPI

MDRPI : Stage 2



แผลกดทับที่เกิดจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
Mucosal Membrane Pressure Injury : MMPI

Mucous Membrane



- ❖ แผลกดทับบริเวณเยื่อเมือก
- ❖ ไม่สามารถระบุแผลกดทับได้

แผลกดทับในห้องผ่าตัด

Definition Of A Perioperative Pressure Injury

Pressure Injury : แผลกดทับที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาทำผ่าตัด ที่มีการบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ปรากฏอาการขึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดและมีความเกี่ยวข้องกับ **Position** ที่ใช้ในการผ่าตัด

A perioperative pressure ulcer is normally defined as any tissue related injury that **presents within 48-72 hours post-operatively and is associated with a surgical position**

48-72 hours post-operatively

Scott S. Progress and Challenges in Perioperative Pressure Ulcer Prevention. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42(5): 480-485.
Black, J., Fawcett, D., & Scott, S. Ten top tips: preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds International 2014; 5(6):
https://www.woundinternational.com/pdf/winter_2015/5_6.pdf. Accessed February 15, 2015.

แผลกดทับในห้องผ่าตัด

The slide shows various diagrams of a patient in different surgical positions (lateral, prone, supine) with padding techniques. It also includes several photographs of skin ulcers at different stages of severity.

แผลกดทับในห้องผ่าตัด

Parkbench position

The slide illustrates the 'Parkbench position' for a patient in a prone position, showing padding for the head, chest, and legs. It includes photographs of ulcers that can result from improper positioning.

Guideline for Perioperative Pressure Injury Prevention

OR Skin Bundle

Scott Triggers*

- Age >62
- Albumin <3.5 or
- BMI <19 or >40
- ASA Score ≥3
- Time on the table ≥3 hr

Score 2 or more = HIGH RISK

OR Skin Bundle

- Skin assessment pre-op and post-op
- Safe patient handling
- High specification OR table pads
- Off loading pressure i.e. heels
- Use special padding for high risk body areas
- Use only approved positioning devices
- Maintain normothermia & microclimate
- Skin Care: Protective dressings
- MDRPUs & MARSI prevention
- Handoff communication
- Post op:
 - Early movement
 - Daily skin assessment
 - Pressure management

Scott S. Journal of Surgical Research 2014; 196: 100-105. doi:10.1016/j.jss.2014.05.005.
*Scott S. Journal of Surgical Research 2014; 196: 100-105. doi:10.1016/j.jss.2014.05.005.
*Scott S. Journal of Surgical Research 2014; 196: 100-105. doi:10.1016/j.jss.2014.05.005.

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแผลกดทับในห้องผ่าตัด:

Trigger Concerned Trigger Tool: Modify Early Warning Signs For Perioperative Pressure Injury Prevention (1)

OR Skin Bundle

- Age >62
- Albumin <3.5 or
- BMI <19 or >40
- ASA Score ≥3
- Time on the table ≥3 hr

Score 2 or more = HIGH RISK

Innovation

The slide contains a flowchart for the MEWS (Modified Early Warning Signs) tool, which assesses the risk of pressure injury based on various patient factors and surgical parameters.

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

MEWS (Modified Early Warning Signs) tool flowchart and table.

MEWS	Score	MEWS	Score
Age >62	1	Time on table >3 hr	1
Albumin <3.5	1	Time on table >3 hr	1
BMI <19 or >40	1	Time on table >3 hr	1
ASA Score ≥3	1	Time on table >3 hr	1
Time on table ≥3 hr	1	Time on table >3 hr	1

The slide also includes a detailed flowchart for the MEWS tool, showing the decision-making process for identifying high-risk patients and implementing preventive measures.

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

วัตถุประสงค์ : ป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัด

KPI

1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง $\geq 80\%$
2. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด $< 2\%$
3. อัตราการเกิดแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในห้องผ่าตัด $= 0\%$

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

Pre-operative (WR)

Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury

Previous Pressure Injury :

☐ No

☐ Yes :Stage.....Site.....

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

Pre-operative (WR) **Intra-operative (OR)**

Operative time ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

☐ Position :

- Prone
- Parkbench / Lateral
- Lithotomy
- Supine

☐ Age ≥ 62

☐ BMI < 19 or > 40

☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

OR Skin Prevention Bundle

- ☐ Maintenance of normothermia
- ☐ Special padding
- ☐ Positioning Devices
- ☐ Polyurethane foam dressing

OR Skin Prevention Bundle

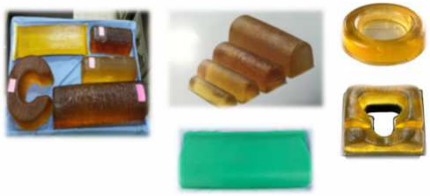
- Maintenance of normothermia**
การควบคุมอุณหภูมิของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมอยู่ในระหว่าง 36°C - 37.5°C

OR Skin Prevention Bundle

- Special padding** : คืออุปกรณ์ที่ใช้ปูบนเตียงผ่าตัดที่ทำจากเจล โฟม ลม หรือน้ำ เพื่อลดแรงกด และ/หรือกระจายแรงกด ระหว่างเนื้อเยื่อได้ ผิวหนังกับเตียงผ่าตัด เช่น แผ่นเจลที่ปูบนเตียงผ่าตัด

OR Skin Prevention Bundle

• **Positioning Devices** : การจัดท่าการผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดท่าที่เหมาะสม ที่ช่วยลดแรงกดบริเวณปุ่มกระดูก ป้องกันแรงไถล และการเสียดสี



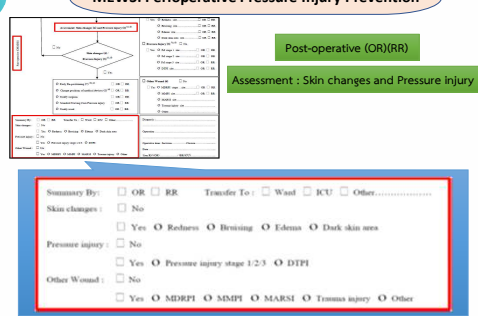
OR Skin Prevention Bundle

• **Polyurethane Foam dressing** : ใช้อุปกรณ์วัสดุปิดแผลในกลุ่มโฟม (foam dressing) ปิดบริเวณปุ่มกระดูกหรือบริเวณผิวหนังที่มีอุปกรณ์การแพทย์กดทับเพื่อลดแรงกด และ/หรือกระจายแรงกด ป้องกันแรงไถล และการเสียดสี



MEWS: Perioperative Pressure Injury Prevention

Post-operative (OR/RR)
Assessment : Skin changes and Pressure injury



Standard Nursing Care Pressure injury

Pressure injury / MDRPI

stage 1

stage 2

DTPI

- ❖ Off loading pressure
- ❖ Change/Off position of medical devices
- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ Polyurethane foam dressing
- ❖ Treatment by doctor order



Standard Nursing Care Pressure injury

MMPI



- ❖ Change/Off position of medical devices
- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ MMPI : Treatment by doctor order

แผลอื่น ๆ ในห้องผ่าตัด

Medical Adhesive Related Skin Injury (MARS)

- MARS คือการเกิดผิวหนังลอกหรือการฉีกขาดจากการใช้วัสดุติดทางการแพทย์ มีการบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดของผิวหนังชั้น Epidermis/Dermis มีอาการผิวหนังแดง หรืออาการแสดงตามชนิดปกติต่าง ๆ ของผิวหนัง เช่น ผื่นน้ำ แผลลอก หรือแผลเปิด **ภายใน 30 นาที** หรือมากกว่า วัสดุติดทางการแพทย์ เช่น Transpore tape, Fixomull, Wound dressing เป็นต้น
- สามารถเกิดได้ทุกตำแหน่ง เกิดได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กทารก



Medical Adhesive Related Skin Injury (MARS)



- ❖ Cleansing with NSS
- ❖ Impregnate gauze (Bactigras, Urgotul/Polyurethane foam dressing/Silicone)
- ❖ Treatment by doctor order

Medical Adhesive Related Skin Injury (MARS)

แนวทางการป้องกัน

- ❖ ประเมินปัจจัยความเสี่ยง เช่น ประวัติการแพ้ ลักษณะผิวหนังของผู้ป่วย
- ❖ เตรียมผิวหนังให้แห้ง สะอาด
- ❖ ไม่ยึด/เพิ่มแรงดึงของวัสดุติดติด ขณะปิดบนผิวหนัง
- ❖ การปิดทับ Catheter : Omega Technique

การลอกวัสดุติดที่ถูกต้อง : Two finger technique ไม่ลอกเร็วเกินไป ตั้งในแนวเดียวกันกับขนของผู้ป่วย และดึงในแนวนอนขนานกับผิวหนังทำมุมไม่เกิน 45 องศา



แผลอื่น ๆ ในห้องผ่าตัด

Trauma injury

- คือ การบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดของผิวหนัง ที่เกิดจากการกระแทก การเสียดสีเป็นต้น ที่ไม่ได้เกิดจากแรงกดทับ และแรงไถร่วมด้วย

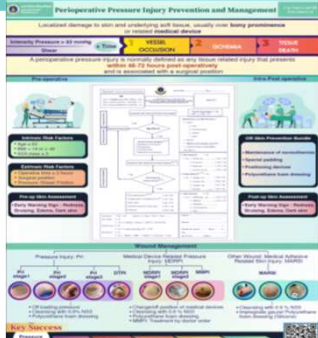
Trauma injury



จาก ET tube หนีปีกจาก DL
หนีปีกจาก DL หนีปีกจาก ET tube

จากการเคลื่อนตัวผู้ป่วย จากการใส่เครื่องมือ

Infographic pressure injury



นวัตกรรม

OR Neuro

นวัตกรรม : รัดและกดขาหนีว ด้วยแผ่นกดทับ

• เทนทอลอง 2564

• ใช้ระบบดูดอากาศในการยึด Reston jelly เพื่อไม่ให้ผิวหนังบริเวณที่ติดกับ Reston jelly โดยตรง ส่งผลดีต่อผู้ป่วย ส่วนคุณสมบัติของแผ่นกดทับ คือมีความนุ่ม สัมผัสสบายตัว

การเผยแพร่ผลงาน

➢ นวัตกรรม "วิธีล็อกขาหนีว" ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานจากทางพยาบาล

➢ ประชุมวิชาการของสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย ปีที่ 1-3 พฤษภาคม 2567

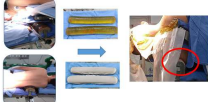
➢ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

➢ ได้รับการคัดเลือกจัดแสดง Poster Presentation

➢ การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25

➢ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568

• Parkbench position : Lower axillary



• Prone position: Chest & Iliac crest



นวัตกรรม

OR Ortho

นวัตกรรม : ยึดหมอนกด

Prone Position



• เทนทอลอง 2559-ปัจจุบัน

• เพื่อป้องกัน/ลดการบิดและกดทับในผู้ป่วยที่ท่าผ่าตัดท้าว (Prone position)

• ใช้ตามรูปแบบการรองรับของเตียงผ่าตัดตำแหน่งท้าว Chest และ Iliac crest

นวัตกรรม **OR Ortho**

นวัตกรรม : อบอุ่นกาย ภายใต้เตียง

- เริ่มทดลองปี 2566
- สำหรับใช้ในการจัดท่าผู้ป่วยนอนคว่ำ เพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
- วัสดุที่ใช้เป็นผ้าชนิดพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่น เบื้องหลังเตียง นุ่นเป็นธรรมชาติระบายความร้อน และระบายความชื้นได้ดี จากการติดกับตัวผู้ป่วย ๓-4 เซ็น เมื่อใช้งานทำให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น สามารถรีไซเคิลได้ใช้ครบรอบก่อนที่พื้นของเตียงจะได้ใหม่



Prone Position



นำไปใช้ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2568
- ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการประชุม The 2nd International Nursing Research Conference ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรม Miracle Grand Convention, Bangkok "

นวัตกรรม **OR Ortho**

นวัตกรรม : ฐานมันคง ปรับรูปทรงในหน้า

- เริ่มทดลองปี 2567
- ส่วนฐานเตียงที่ปรับองศาได้จะเกิดการยุบตัว ทำให้องศาเตียงในส่วนที่รองรับผู้ป่วยมีปัญหา เมื่อวางผู้ป่วยไว้ที่เตียงแบบนอนหงาย ตัวของผู้ป่วยจะนอนหงาย ไม่สามารถปรับองศาเตียงได้ ทำให้เกิดอาการกระดูกงอตัวมากขึ้น ส่งผลให้มีรอยกดอยู่ที่จุดกระดูกงอมากขึ้น เป็นเวลานาน เกิดปัญหาและกดทับบริเวณ หน้าขา ลูกตา โหนกแก้มและดวง รวมถึงข้อช่วยหายใจถูกกด



Prone Position



ตัดแผ่นพลาสติก PETG

นำไปใช้ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

- ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E - Poster) ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนำเสนอผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E - Poster) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2569 ณ อาคารอิมพีค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นวัตกรรม **OR Ortho**

นวัตกรรม : ห่อหุ้ม นุ่มผิว

- เริ่มทดลองปี 2568
- การผ่าตัดข้อสะโพกหัก Hip fracture
- Hemi-lithotomy สำหรับทำผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานและปรับดึงตัวน้ำหนัก Traction
- เปลี่ยนจากผ้าเป็นผ้า Polyester เพื่อใช้ห่อหุ้ม Perineal Post ก่อนการจัดท่าผู้ป่วย ที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น และมีการระบายอากาศดี และใช้เพื่อปรับองศาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย จากกันับผู้ป่วย ระหว่างวัน เริ่มมาใช้ได้ทันที นำมาใช้ทดแทนเข็มเย็บ 2
- เพื่อลดแรงกดทับและแรงเสียดสี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ รวมถึงการบาดเจ็บของผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทบริเวณอุ้งเชิงกราน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดบนเตียง Fracture table ได้ดียิ่งมีประสิทธิภาพ



Perineal Post

นวัตกรรม **OR EYE**

นวัตกรรม : 3-wall PT Protector

- เริ่มทดลองปี 2565
- อุปกรณ์ 15 S
- GA
- Operation Time > 3 ชั่วโมง
- ป้องกันการกดทับบริเวณหน้าตาของผู้ป่วย



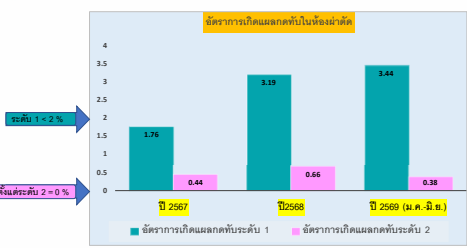
การเผยแพร่ผลงาน

- โครงการติดตาม ปี 2568
- รางวัลนวัตกรรม ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ ปี 2566

รายงานตัวชี้วัด ผลกดทับในห้องผ่าตัด

รายงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์			
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
		รวม	ม.ค.-มิ.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	
1) อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	≥ 80%	97.73	99.01	99.72	99.90
2) อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด	< 2%	1.76 (79 ราย)	3.19 (139 ราย)	3.41 (37 ราย)	3.48 (36 ราย)
3) อัตราการเกิดแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในห้องผ่าตัด	0%	0.44 (20 ราย)	0.66 (29 ราย)	0.46 (5 ราย)	0.29 (3 ราย)

รายงานตัวชี้วัด ผลกดทับในห้องผ่าตัด



อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

ปี 2567 ปี 2568 (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.)

อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

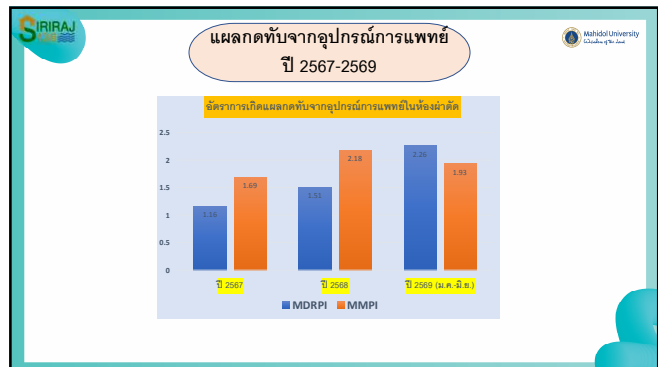
อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

SRIRAJ

แผนกตับระดับ 1-2 ปี 2567-2569

Mahidol University
Chulalongkornrajavidyalaya

หน่วยงาน	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (น.ค.-ธ.ค.)	
	ระดับ 1 จำนวนราย	ระดับ 2 จำนวนราย	ระดับ 1 จำนวนราย	ระดับ 2 จำนวนราย	ระดับ 1 จำนวนราย	ระดับ 2 จำนวนราย
Eye	0	0	0	0	0	0
Ortho	3	3(DTPH+1)	4	14	1	2
ENT	1	0	0	0	0	0
CVT	0	0	3	2	1	0
Neuro	71	18(DTPH+1)	130	10	71	5
Plastic	1	0	2	1	0	1(DTPH)
Head Neck	0	0	0	0	0	0
Pediatric	0	0	0	0	0	0
Gen-Vas	1	2	2	1	0	0
Urology	2	0	1	1(DTPH)	0	0
Trauma	0	0	0	0	0	0
Emer (Acute care)	0	0	0	0	0	0
รวม	79	20	139	29	73	8



SRIRAJ

แผนกตับจากอุปกรณ์การแพทย์ ปี 2567-2569

Mahidol University
Chulalongkornrajavidyalaya

หน่วยงาน	ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569 (น.ค.-ธ.ค.)		
	MDRPI		MMPI	MDRPI		MMPI	MDRPI		MMPI
	Stage 1 จำนวนราย	Stage 2 จำนวนราย		Stage 1 จำนวนราย	Stage 2 จำนวนราย		Stage 1 จำนวนราย	Stage 2 จำนวนราย	
Eye	1	0	1	0	1	3	0	0	0
Ortho	3	3(DTPH+1)	13	4	18(DTPH+1)	9	0	3	4
ENT	7	3(DTPH+2)	46	4	1(DTPH+1)	67	3	1	31
CVT	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Neuro	27	3	7	4	1	12	30	1	2
Plastic	2	0	4	4	1	2	0	1	1
Head Neck	1	0	1	4	0	0	2	0	0
Pediatric	0	0	1	4	0	0	0	0	0
Gen-Vas	0	2	2	4	1	0	0	1	2
Urology	0	0	1	4	1	1	4	1(DTPH+1)	1
Trauma	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Emer (Acute care)	0	0	0	4	0	0	0	0	0
รวม	41	11	76	52	14	95	40	6	41

SRIRAJ

แผลอื่น ๆ ในห้องผ่าตัด ปี 2567-2569

Mahidol University
Chulalongkornrajavidyalaya

Medical Adhesive Related Skin Injury (MARS)

หน่วยงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (น.ค.-ธ.ค.)
	จำนวนราย	จำนวนราย	จำนวนราย
Eye	1	3	1
Ortho	18	7	6
ENT	14	20	8
CVT	0	4	0
Neuro	18	31	5
Plastic	2	1	0
Head Neck	1	1	0
Pediatric	0	0	0
Gen-Vas	7	3	6
Urology	1	9	2
Trauma	0	0	0
Emer (Acute care)	0	0	0
รวม	62	79	28

SRIRAJ

รายงานตัวชี้วัด หน่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวชปี 2567-2568

Mahidol University
Chulalongkornrajavidyalaya

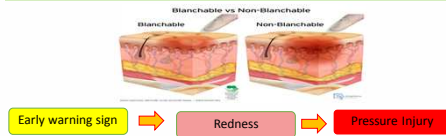
รายงานตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์			
		ปี 2567		ปี 2568	
		Gynecology N = 554 ราย	Obstetrics N = 4 ราย	Gynecology N = 506 ราย	Obstetrics N = 25 ราย
1) อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง	≥ 80%	85.20	75	86.56	84
2) อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในห้องผ่าตัด	< 2 %	0.18	0	0	0
3) อัตราการเกิดแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 ในห้องผ่าตัด	0%	0	0	0	0

วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- ประสิทธิภาพการผ่าตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน **ระยะเวลาการผ่าตัดนานมากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป** โดยเฉพาะการผ่าตัดทางระบบประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- มีการใช้อุปกรณ์จัดทำ และหรืออุปกรณ์เพื่อรัดตัวผู้ป่วยกับเตียงผ่าตัดเพื่อป้องกันการตกเตียง ทำให้เพิ่มแรงกดทับบนตัวผู้ป่วย
- มีการปรับเปลี่ยนท่าโดยการปรับเตียงผ่าตัดขึ้น-ลง เอียงซ้าย-ขวา ในขณะที่ผ่าตัด ทำให้เกิดแรงไถลและการเสียดสี โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับเตียงผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมากขึ้น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างผิวหนังผู้ป่วยกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับมากขึ้น

การติดตาม และการรายงานแผลกดทับ

- จัดทำ Template รายงาน KPI ทุก 1 เดือน
- การรายงานแผลกดทับตั้งแต่ระดับ 2 (Pr1 / MDRPI)
 - ❖ รายงานอุบัติการณ์ ส่งใน SIRM
 - ❖ ถ่ายรูปแผล ใบอุบัติการณ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนบใบ MEWS ส่งใน SIVwork กลุ่ม KM
 - ❖ วิเคราะห์หาสาเหตุ
- การรายงานแผลกดทับ MMPI และแผลประเภทอื่นๆ เช่น MARSII แผลเปิด , Trauma injury เป็นต้น
 - ❖ ถ่ายรูปแผล และหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนบใบ MEWS ส่งใน SIVwork กลุ่ม KM



Early warning sign → Redness → Pressure Injury

Wound Assessment & Management Guidance Application

เครื่องมือการประเมินแผล และให้คำแนะนำการจัดการแผล
ที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
Developed in collaboration with Siriraj ET Nursing Team

พร้อมใช้งานแล้ว
Scan to open the application



Supported by Corvatec Thailand

THANK YOU!

